Клинические рекомендации

Доброкачественные остео- и хондрогенные опухоли носа и пазух

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D14.0** — Среднего уха, полости носа и придаточных пазух
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/756_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 4

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 4

3.1 Жалобы и анамнез 4

3.2 Осмотр 5

3.3 Передняя риноскопия и видеориноскопия 5

3.4 Компьютерная томография носа и околоносовых пазух 5

3.5 МРТ и консультации специалистов 5

3.6 Биопсия 6

4. Лечение 6

4.1 Остеома 6

4.2 Фиброзная дисплазия 7

4.3 Другие опухоли 7

4.4 Лучевая терапия 7

4.5 Рецидивы после удаления 8

4.6 Хондрома: другие доступы 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 8

5.1 Показания к госпитализации 8

5.2 Реабилитация и наблюдение 8

6. Источник и актуальность 8

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Доброкачественные костные и хрящевые опухоли носа и околоносовых пазух:
  1. остеома;
  2. остеобластома;
  3. фиброзная дисплазия;
  4. аневризматическая костная киста;
  5. оссифицирующая фиброма;
  6. гигантоклеточная опухоль;
  7. хондрома и другие хрящевые опухоли.

  Наиболее часто встречается остеома лобной пазухи.
- Стойкий или прогрессирующий на фоне лечения односторонний воспалительный процесс в полости носа и пазухах требует исключения опухоли: показаны КТ носа и околоносовых пазух, при необходимости биопсия.
- Диагноз устанавливается на основании жалоб, анамнеза, осмотра, эндоскопии полости носа и КТ носа и околоносовых пазух.
- Лечение хирургическое. При небольшой бессимптомной остеоме допустима выжидательная тактика. После операции выполняется контрольная КТ через **3–6 месяцев**, затем через **1 год и более**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Опухоли

Опухоль	Определение
Остеома	медленно растущая (0,44–6,0 мм в год) опухоль из костной ткани; случаев малигнизации не описано
Остеобластома	редкая опухоль из костной ткани, продуцирующая ретикуло-фиброзные перекладины, окружённые крупными остеобластами
Фиброзная дисплазия	опухолевидное поражение: разрушение костной ткани с деформацией и заполнением костномозгового канала фиброзной тканью
Аневризматическая костная киста	редкое заболевание кости с локальным деструктивным и экспансивным ростом
Оссифицирующая фиброма	опухоль из кальцификатов, цемента, костной и фиброзной ткани; ювенильная форма течёт агрессивнее
Гигантоклеточная опухоль (остеокластома)	редкое новообразование кости с локально-агрессивным, деструктивным ростом
Хондрома	истинная опухоль из хрящевой ткани с длительным развитием: от 3 месяцев до 10 лет
Хондромиксоидная фиброма	редкая опухоль из веретеновидных или звёздчатых клеток в миксоидной или хондроидной строме
Хондробластома	редкая опухоль из хондробластов
Носовая хондромезенхимальная гамартома	опухоль из веретенообразных клеток, хрящевой ткани и геморрагических кист

2.2 Этиология

Причины окончательно не установлены. К возможным факторам риска относятся нарушение эмбриогенеза, инфекция, травма; при фиброзной дисплазии основную роль играет мутация гена GNAS1.

2.3 Классификация

Общепринятой классификации нет; классификации отдельных опухолей рабочие и учитываются при планировании лечения.

Рабочие классификации

1. остеома по строению: компактная, губчатая, смешанная;
2. остеобластома по скорости роста: латентная, активная, агрессивная;
3. фиброзная дисплазия: моноостальная (70–85%) и полиостальная (15–30%);
4. аневризматическая костная киста, фазы: остеолиз, отграничение, восстановление;
5. хондрома: энхондрома (внутри кости) и экхондрома (на поверхности кости).

2.4 Клиническая картина

Жалобы, как правило, связаны с ростом опухоли, её давлением на стенки пазух и (или) распространением на смежные области. Опухоли небольших размеров обычно не сопровождаются жалобами и могут быть случайной находкой при рентгенологическом обследовании.

Частые жалобы

1. головная боль в носо-лицевой области, в проекции пазухи;
2. заложенность носа, аносмия — при обтурации соустья, вторичном синусите, мукоцеле;
3. рецидивирующие носовые кровотечения — при аневризматической костной кисте;
4. асимметрия и безболезненный отёк лица — при фиброзной дисплазии;
5. головная боль, нарушение зрения, тригеминальная гиперчувствительность, парез глазных мышц — при гигантоклеточной опухоли клиновидной кости.

Распространение на орбиту и в полость черепа

1. деформация носоглазничной области, проптоз, периорбитальная боль, хемоз, диплопия, периорбитальная эмфизема;
2. слезотечение — при сдавлении носослёзного канала;
3. снижение зрения — при сдавлении зрительного нерва;
4. общемозговые и очаговые симптомы, менингит, абсцесс мозга — при интракраниальном распространении.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается по жалобам, анамнезу, физикальным данным, эндоскопической ревизии полости носа и носоглотки и КТ носа и околоносовых пазух.

Симптомы неспецифичны и в начале заболевания минимальны. Выраженная клиническая картина отсутствует в 4–10% случаев остеомы, а случайно эта опухоль обнаруживается при КТ у 1–3% обследованных.

3.1 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. сроки, последовательность и динамику жалоб;
2. прежние травмы и заболевания носа и пазух, их лечение и эффект;
3. результаты прежних обследований: анализы, КТ, МРТ, биопсия, протоколы операций;
4. похожие жалобы у близких родственников.

3.2 Осмотр

Общий осмотр, пальпация и перкуссия носо-лицевой области, пальпация подчелюстных, подподбородочных и глубоких шейных лимфоузлов. Для доброкачественных опухолей изменения регионарных лимфоузлов не характерны.

3.3 Передняя риноскопия и видеориноскопия

Выполняется всем пациентам.

Оценивают

1. преддверие носа и передние отделы слизистой оболочки полости носа;
2. нижнюю и среднюю носовые раковины, перегородку носа;
3. наличие и характер отделяемого в носовых ходах;
4. новообразование в передних отделах полости носа или распространяющееся туда из глубоких отделов, обтурирующее полость носа.

Видеориноскопия риноскопом или фиброскопом показана всем пациентам. Первичный осмотр целесообразно выполнять без подготовки полости носа и анестезии.

3.4 Компьютерная томография носа и околоносовых пазух

Показания

1. подозрение на опухоль носа и околоносовых пазух: КТ от плоскости твёрдого нёба до верхней границы лобной пазухи, толщина среза **2 мм**.

Оценивают

1. локализацию, распространённость и размеры новообразования;
2. структуру новообразования;
3. кальцификацию;
4. ремоделирование прилежащей костной ткани.

Остеома на КТ

1. компактная: округлое плотное почти бесструктурное образование;
2. губчатая: грубо-трабекулярная структура;
3. смешанная: зона 300–600 ед. Н губчатого строения и зона более 800 ед. Н компактного вещества.

Фиброзная дисплазия на КТ — однородная ткань «матового стекла» плотностью около 300–450 ед. Н, не инкапсулирована; кистозная форма — с участками более низкой плотности.

Остеобластома на КТ — сочетание плотной кости и участков затемнения.

Хондрома на КТ — образование гетерогенной плотности с чёткими границами и очагами минерализации.

Остеохондрома на КТ — костное вещество неоднородной плотности в центре, ткань хрящевой плотности по периферии.

3.5 МРТ и консультации специалистов

МРТ и консультации челюстно-лицевого хирурга, офтальмолога, нейрохирурга позволяют выявить распространение опухоли на верхнюю челюсть, глазницу и в полость черепа.

Обязательны при

1. изменениях зубочелюстной системы: смещение, расшатывание, выпадение зубов, деформация;
2. глазных симптомах: проптоз, периорбитальная боль, хемоз, диплопия, слезотечение;
3. менингеальных и очаговых неврологических симптомах.

3.6 Биопсия

По показаниям выполняется биопсия и патологоанатомическое исследование с иммуногистохимией для дифференциальной диагностики доброкачественной и злокачественной опухоли.

Способы биопсии

1. прицельная биопсия под эндоскопом: материал берут на границе опухоли с неизменёнными тканями;
2. эксцизионная биопсия: при небольших размерах опухоли;
3. аспирационная биопсия иглой: при кистозном образовании, солидной опухоли;
4. цитологическое исследование отпечатка или мазка-отпечатка со слизистой оболочки: в отдельных случаях.

---

4. Лечение

Лечение хирургическое: эндоназальный, наружный или комбинированный доступ. Применение навигационного оборудования повышает эффективность и безопасность вмешательства.

Экстраназальные доступы при значительной распространённости опухоли

1. транспалатинный;
2. боковая ринотомия;
3. краниофациальная резекция;
4. срединный декортикационный доступ (midfacial degloving).

4.1 Остеома

Для удаления остеомы применяют эндоназальный (эндоскопический), наружный или комбинированный доступ; способ зависит от размеров опухоли и места её прикрепления к стенке пазухи. Наружный доступ более травматичен: возможны послеоперационный эстетический дефект, парестезии, прозопалгия.

При небольшой бессимптомной остеоме рекомендуется выжидательная тактика. По некоторым данным, к операции следует прибегать при остеоме, занимающей **более 50%** объёма пазухи. Рецидивы редки и возникают, как правило, через **5–8 лет**.

Классификация остеом лобной пазухи по A. G. Chiu, 2005

Степень	Остеома лобной пазухи
1	прикреплена сзади-снизу, медиальнее плоскости бумажной пластинки; переднезадний размер меньше 75% лобного кармана
2	то же расположение, переднезадний размер больше 75% лобного кармана
3	прикреплена спереди или сверху и (или) выходит латеральнее плоскости бумажной пластинки
4	полностью обтурирует лобную пазуху

Эндоскопическое удаление

1. предпочтительно при остеомах 1 и 2 степени, описано и успешное удаление 3 и 4 степени;
2. относительное ограничение: большие остеомы задне-верхних отделов лобной пазухи (из-за длительности вмешательства);
3. не показано при остеоме на передней и нижней стенке латеральных отделов лобной пазухи;
4. интраорбитальное и интракраниальное распространение не является абсолютным противопоказанием.

4.2 Фиброзная дисплазия

В связи с возможностью регресса рекомендуется выжидательная тактика с постоянным наблюдением и периодической КТ.

Показания к хирургическому лечению

1. выраженная костная деформация;
2. возраст пациента;
3. ограниченная распространённость изменений.

Медикаментозная терапия

1. бифосфонаты: профилактика патологических переломов и боли; существует риск остеонекроза челюсти;
2. при синдроме Мак-Кьюна — Олбрайта: терапия для купирования эндокринных нарушений.

Показания к эндоскопической хирургии

1. облегчение симптомов риносинусита, ассоциированного с фиброзной дисплазией;
2. декомпрессия зрительного нерва.

Эффективность декортикации стенок верхнечелюстной пазухи требует доказательств.

4.3 Другие опухоли

Лечение по виду опухоли

Опухоль	Лечение
Остеобластома	хирургическое удаление эндоназальным, наружным или комбинированным доступом с учётом локализации, размеров и места прикрепления опухоли
Аневризматическая костная киста	хирургическое удаление: от пункции полости кисты до кюретажа и резекции поражённого участка кости; предоперационная эмболизация питающих сосудов
Оссифицирующая фиброма	возможно более раннее и полное удаление: краниофациальная резекция, латеральная ринотомия, midfacial degloving или эндоскопическая диссекция; продолжительное послеоперационное наблюдение
Гигантоклеточная опухоль	хирургическое удаление; длительное динамическое наблюдение
Хондрома	хирургическое удаление из-за риска малигнизации и разрушения стенок; предпочтительно эндоскопическое удаление, а при распространении опухоли в верхнечелюстную пазуху и орбиту — гайморотомия по Денкеру
Хондромиксоидная фиброма	хирургическое удаление; предпочтительна широкая эксцизия эндоскопически или доступом midface degloving
Хондробластома	радикальное иссечение

4.4 Лучевая терапия

1. при гигантоклеточной опухоли лучевая терапия может быть рекомендована, если локализация ограничивает радикальное удаление или требует инвалидизирующего вмешательства;
2. при аневризматической костной кисте она возможна, но нежелательна из-за риска малигнизации (трансформации в саркому);
3. при оссифицирующей фиброме она оказалась неэффективной и потенциально опасна из-за вероятности малигнизации опухоли.

У остеобластомы описан случай малигнизации после лучевой терапии.

4.5 Рецидивы после удаления

1. остеобластома: после радикального удаления рецидивов нет в течение 5–15 лет; у детей частота рецидивов достигает 32%;
2. аневризматическая костная киста: рецидивы в 10–30% случаев, чаще в течение **первых двух лет**;
3. ювенильная оссифицирующая фиброма: до 30% даже при полном удалении, риск сохраняется до 18 лет;
4. гигантоклеточная опухоль: частота рецидивов зависит от распространённости, данных для носа и пазух нет;
5. хондромиксоидная фиброма: кюретаж эффективен в 80%; многократные рецидивы описаны и после радикальной операции; при иссечении единым блоком рецидивов меньше, но операция травматичнее;
6. хондробластома: при одном кюретаже рецидивы достигают 55%.

4.6 Хондрома: другие доступы

1. радикальное удаление распространённой хондромы носа и околоносовых пазух может быть затруднено осложнениями во время операции, в частности кровотечением;
2. в некоторых случаях при такой локализации прибегают к чрезнёбному или наружному (боковая ринотомия) доступу;
3. хондрому носовых костей можно успешно удалить доступом, используемым при наружной ринопластике.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализация

1. доброкачественная остео- или хондрогенная опухоль носа и пазух без противопоказаний к плановой операции.

Выписка

1. нет осложнений, удовлетворительное общее состояние.

5.2 Реабилитация и наблюдение

После удаления опухоли рекомендуется охранительный режим **10–14 дней и более**.

Специфической профилактики нет. После операции необходимо динамическое наблюдение: КТ **через 3–6 месяцев**, затем **через 1 год и более**, в зависимости от вида опухоли, локализации и радикальности операции.

Прогноз зависит от гистологии, локализации и распространённости. Радикальное удаление, как правило, приводит к излечению, однако из-за рецидивов и возможной малигнизации необходимо динамическое наблюдение.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Доброкачественные остеогенные и хондрогенные опухоли носа и околоносовых пазух»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 04.03.2023
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее марта 2026 года
Код в рубрикаторе	756_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В критериях оценки качества уровни доказательности (КТ — УУР А, УДД 1; операция — А, 4; охранительный режим — В, 2) не совпадают с уровнями этих рекомендаций в тексте (С, 4–5).